

**EPREUVE D'ONCOLOGIE-HEMATOLOGIE
SESSION JANVIER 2026**

1-Dans une aplasie médullaire on retrouve :

- A-Des angines
- B-Une hypertrophie gingivale
- C-Une adénopathie
- D- Une fièvre
- E- Une anémie

2-Quelles sont les propositions justes concernant l'anémie de Fanconi :

- A-Aplasie médullaire acquise
- B-Présence d'un syndrome poly-malformatif
- C- Est d'installation progressive
- D- Le caryotype objective des cassures chromosomiques
- E- L'allo-greffe est le seul traitement curatif

3-Un enfant de 5 ans présente un tableau d'invagination intestinale aiguë. La biopsie a objectivé des cellules lymphomateuses ; Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A-Un lymphome de Mantoux
- B-Une tuberculose intestinale
- C-Un lymphome de Burkitt
- D-Une métastase d'un cancer
- E-Un lymphome de Hodgkin

4-L'hémophilie A :

- A-Est un déficit constitutionnel en facteur VIII
- B- Est transmise selon le mode récessif lié au sexe
- C- Les hématomes sont liés à une thrombopénie
- D- Peut se compliquer d'une arthropathie
- E- Peut se compliquer d'un inhibiteur circulant

5-Au cours du purpura thrombopénique immunologique :

- A-Les bulles hémorragiques buccales sont un signe de gravité
- B-L'examen au fond d'œil n'a aucun intérêt pronostic
- C-Le pronostic est meilleur chez l'enfant que chez l'adulte
- D-L'étiologie médicamenteuse doit être recherchée
- E-La transfusion en plaquettes sanguines n'a aucun intérêt

6- Quelle est parmi ces complications celle qui ne s'observe pas au cours de la thalassémie majeure ?

- A- La crise vaso-occlusive
- B-Les infections
- C-L'hypersplénisme
- D-La lithiase biliaire
- E-Le retard staturo-pondéral

7- La thalassémie hétérozygote

- A-Est plus fréquente que la thalassémie homozygote
- B- Est asymptomatique
- C- Est appelée 'trait thalassémique'
- D- Nécessite des transfusions régulières du malade
- E- Se caractérise par une pseudo polyglobulie

8- Un patient âgé de 60 ans qui a des douleurs osseuses et syndrome anémique ; un myélome multiple est évoqué quels sont les bilans à demander à visée diagnostique ?

- A-Hémogramme
- B-Électrophorèse des protéines
- C-Myélogramme
- D-Bilan rénal
- E- Caryotype médullaire

9- Une patiente de 12 ans se présente aux urgences pour une altération de l'état générale dans un contexte fébrile, à l'examen clinique elle présente une pâleur, des ecchymoses et une splénomégalie, parmi les propositions suivantes quelles sont les propositions justes :

- A- La patiente présente un syndrome d'insuffisance médullaire
- B- La patiente présente un syndrome tumoral
- C- la patiente présente un syndrome infiltratif
- D- La patiente présente un syndrome cave supérieur
- E- Un hémogramme est indiqué en urgence

10- Le bilan chez cette patiente a objectivé : hb à 6 g/dl, GB : 70000/ μ l, Pq : 34 000/ μ l; Quels sont les diagnostics à évoquer ?

- A- Leucémie aigüe lymphoblastique
- B- Leucémie aigüe myéloblastique
- C- Aplasie médullaire
- D- Leucémie lymphoïde chronique
- E- Myélodysplasie

11- Dans le lymphome de Hodgkin, le diagnostic de confirmation est basé sur

- A- La biopsie ganglionnaire
- B- La cytoponction
- C- Le myélogramme
- D- Le pet scan
- E- La TDM

12- Un patient âgé de 75 ans qui se présente pour céphalées et érythrose faciale, a une splénomégalie et son bilan a objectivé une hb à 19g/dl, Hte : 50% , GB : 34000/ μ l, et des pq : 400 000/ μ L :

- A- Le patient présente un syndrome d'hyperviscosité sanguine
- B- Le bilan objective une polyglobulie
- C- L'hyperleucocytose est en faveur de l'origine secondaire
- D- La thrombocytose est en faveur de l'origine primitive
- E- La splénomégalie est en faveur de la maladie de Vaquez

13- Quel est le bilan étiologique à demander chez ce patient ?

- A-Myélogramme
- B-Biopsie ostéomédullaire
- C-Dosage Érythropoïétine
- D- Recherche de la mutation Jak2
- E-Masse sanguine isotopique

14- Chez une patiente de 45 ans avec syndrome anémique chronique, un bilan a objectivé hb : 5 g/dl, VGM : 115, GB : 9000/ μ l et des pq : 200 000/ μ l et une ferritine : 100 ng/ml, quel est le diagnostic le plus probable :

- A-Anémie ferriprive
- B-Anémie mégaloblastique
- C-Anémie inflammatoire
- D-Beta-thalassémie
- E-Déficit en G6PD

15- Chez un patient âgé de 80 ans, une leucémie lymphoïde chronique a été évoquée devant une polyadénopathie avec hyperlymphocytose, quelles sont les propositions justes ?

- A- Le diagnostic est confirmé par biopsie ganglionnaire
- B- Le frottis sanguin montre des ombres de Gumprecht
- C- L'immunophénotypage sur sang confirme le diagnostic
- D- le myélogramme est indispensable au diagnostic
- E- La classification pronostique est basée sur le PET scan

16- La drépanocytose est :

- A- Une hémoglobinopathie acquise
- B- Se manifeste par une anémie hémolytique chronique
- C- Peut se compliquer de crises vaso-occlusives
- D- Hypersplénisme est une complication fréquente
- E- Le traitement est basé sur des transfusions régulières avec des seuils transfusionnels à 11 g/dl

17- Le traitement de la crise drépanocytaire est basé sur :

- A- L'oxygénation
- B- L'hyperhydratation alcaline
- C- Le traitement antalgique est à différer
- D- Le traitement antibiotique si signe d'infection
- E- La transfusion est contre indiquée

18- Dans le déficit en G6PD :

- A- L'hémolyse est surtout intratissulaire
- B- La crise hémolytique est une urgence transfusionnelle
- C- La splénomégalie est un signe caractéristique
- D- La coloration des urines rouge porto est très évocatrice
- E- L'ictère et les douleurs lombaires sont des symptômes fréquents

19- Le traitement du déficit en G6PD est basé sur

- A- La splénectomie
- B- L'éviction des antioxydants
- C- Un programme transfusionnel régulier
- D- La supplémentation en fer
- E- La supplémentation en acide folique

20- Le diagnostic d'anémie ferriprive est suspecté devant :

- A. Une anémie microcytaire hypochrome
- B. Une anémie normocytaire normochrome
- C. Une anémie macrocytaire normochrome
- D. Une microcytose sans anémie
- E. Une anémie macrocytaire hyperchrome

21- Le diagnostic d'anémie ferriprive (carence absolue) est confirmé devant :

- A. Un fer sérique bas, une ferritine élevée et une CRP élevée
- B. Une ferritine basse et une CRP normale
- C. Un dosage de vitamine B12 bas
- D. Un dosage d'acide folique bas
- E. Une élévation de l'hémoglobine A2 à l'électrophorèse

22- Le traitement de l'anémie ferriprive repose sur :

- A. La supplémentation en fer jusqu'à normalisation de l'hémoglobine
- B. La supplémentation en fer jusqu'à normalisation du fer sérique
- C. La supplémentation en fer jusqu'à normalisation de la ferritine
- D. La supplémentation en vitamine B12 à vie
- E. La transfusion de globules rouges systématique

23- Concernant le bilan étiologique d'une anémie ferriprive :

- A. Il est facultatif
- B. Il se fait en seconde intention après échec du traitement de l'anémie par le fer
- C. Il doit être systématique chez tous les patients
- D. Il fait appel, chez la femme, à un examen gynécologique complet, et une exploration digestive, si l'examen gynécologique est négatif
- E. Il fait appel chez l'homme, à une exploration digestive (endoscopie digestive haute et basse)

24- Concernant la leucémie myéloïde chronique, toutes les réponses sont justes sauf une. Laquelle ?

- A. C'est une hémopathie clonale de la cellule souche hématopoïétique
- B. Elle est définie par la présence du chromosome de Philadelphie ou son correspondant moléculaire (le gène Bcr-Abl)
- C. L'hémogramme montre souvent une hyperleucocytose avec une myélémie équilibrée au frottis sanguin
- D. Elle évolue en trois phases (chronique, accélérée et blastique)
- E. Le traitement repose sur la chimiothérapie intensive

25- La leucémie myéloïde chronique : L M C

- A. Est suspectée devant une hyperleucocytose avec myélémie et des blastes supérieurs à 30% au frottis sanguin
- B. Est suspectée devant une hyperleucocytose avec myélémie sans hiatus de maturation et des blastes inférieurs à 30% au frottis sanguin
- C. Est confirmée par la présence la translocation (9, 22) ou son correspondant moléculaire le gène Bcr-Abl
- D. Est traitée par les inhibiteurs de tyrosine kinase (ex. imatinib, nilotinib, dasatinib)
- E. Est une maladie bénigne nécessitant une simple surveillance des formes asymptomatique

26- L'épidémiologie des cancers a comme objectifs :

- A. Identifier les facteurs de risque
- B. Définir les populations à risque
- C. Élaborer une stratégie préventive contre le cancer
- D. Étudier la répartition des cancers dans une population
- E. Calculer la fréquence des cancers dans différentes populations

27- Selon la nouvelle édition du registre des cancers de la grande région de Casablanca :

- A. Le premier cancer chez l'homme est le cancer de la prostate
- B. Le premier cancer chez la femme est le cancer du sein
- C. Le cancer du col utérin est le 2^{ème} cancer chez la femme
- D. Le cancer bronchopulmonaire est le 2^{ème} cancer.
- E. Le cancer colo-rectal est le 3^{ème} cancer

28- L'épidémiologie descriptive s'intéresse à l'étude de:

- A. La prévalence
- B. L'incidence
- C. La mortalité
- D. La mortalité spécifique
- E. Risque relatif

29- L'étude cas témoin

- A. Est un outil très intéressant de l'épidémiologie descriptive
- B. Est adaptée aux cancers rares
- C. Est couteuse
- D. Difficile à réaliser dans les cancers fréquents
- E. Ne permet pas de calculer le risque relatif

30- Le tamoxifène :

- A. A un effet contraceptif
- B. Permet une castration médicale périphérique réversible
- C. Peut donner un cancer du sein par son action hormonale sur l'endomètre
- D. Nécessite la prescription d'un contraceptif hormonale concomitant
- E. Toutes les réponses sont fausses

31- La prescription d'une hormonothérapie dans le cancer de la prostate :

- A. Nécessite obligatoirement la recherche des récepteurs hormonaux
- B. Peut associer une chimiothérapie
- C. Peut être faite en association à la radiothérapie
- D. Est limitée dans le temps en adjuvant
- E. Nécessite un taux du PSA élevé

32- Les rayonnements utilisés en radiothérapie externe peuvent être :

- A. Corpusculaires chargés
- B. Électromagnétiques
- C. De type gamma
- D. De basse énergie
- E. Des protons

33- L'action des radiations ionisantes :

- A- Cible exclusivement la cellule cancéreuse
- B- Peut générer des cancers radio-induits
- C- Est potentialiser par l'association à une chimiothérapie
- D- Cible exclusivement l'ADN
- E- Toutes les réponses sont fausses

Mr A M, 71 ans diabétique type 2 depuis 16 ans sous (Glucophage 1000 mg, 1cp x 3 / j), se présente aux urgences pour une rétention aigue d'urines, l'examen physique confirme la présence d'un globe vésical, vous décidez de placer une sonde urinaire qui ramène 2 L d'urines d'aspect claires, le malade est enfin soulagé. Il rapporte à l'interrogatoire que depuis plus 2 mois, il a des mictions fréquentes surtout la nuit l'obligeant à se réveiller plusieurs fois ce qu'il attribue à un probable déséquilibre glycémique (son dernier contrôle avec l'endocrinologue remonte à plus de 6 mois), en plus depuis 15 jours il accuse des lombalgies gauches irradiant le long du MI gauche non soulagées par les AINS.

À L'examen sa douleur est chiffrée à 8 selon l'EVA, douleur exquise à la pression des épineuses lombaires

34- Quel (s) traitement (s) allez-vous prescrire pour assurer une antalgie immédiate ?

- ☒ A- Morphine
- ☐ B- Tramadol
- ☐ C- Paracétamol
- ☐ D- Oxycodone
- ☐ E- Tramadol + Morphine

Après 60 min Mr A M retrouve son sourire , il est bien calmé son EVA est chiffrée à 1

35- Quel traitement à associer systématiquement avec votre traitement antalgique initialement prescrit ?

- ☒ A- Oméprazole
- ☐ B- Lactulose
- ☐ C- Métoprolol
- ☐ D- Kétoprofène
- ☐ E- Codéine

36 - Votre patient consulte un urologue et le toucher rectal objective une prostate indurée, le dosage du PSA revient à 150 ng/ml. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A- Une hypertrophie bénigne de la prostate
- B- Une prostatite aigüe
- C- Un cancer de la prostate
- D- Un cancer du rein
- E- Une tumeur de la vessie

37 - Votre diagnostic est confirmé, quel (s) bilan (s) à réaliser chez ce patient afin d'apprécier l'extension à distance :

- A- TDM pelvienne
- B- IRM dorso-lombaire
- C- TDM thoraco-abdominopelvienne
- D- Pet-scan au FDG
- E- Scintigraphie osseuse

Madame H K, 65 ans, est suivie au service d'oncologie médicale pour un cancer du sein où elle vient de recevoir sa 2^{ème} séance de chimiothérapie selon le protocole AC60 il y a 13 jours, se présente aux urgences de proximité pour une sensation de fatigue généralisée associée à de la fièvre, elle rapporte à l'interrogatoire une notion de brûlures mictionnelles depuis 02 jours . L'examen retrouve une T 38.5, TA 13/7 pouls 66 bat/min, l'auscultation pulmonaire est normale

38- Quel est le bilan de première intention à réaliser chez cette patiente :

- A ECBU
- B NFS
- C Ionogramme sanguin
- D CRP
- E mammographie

Les bilans réalisés objectivent une CRP positive à 56, Na : 136 , K : 4.5 , créatinine : 7mg/l

Hémoglobine à 11g/dl , GB⁺ : 3300 /mm³ , PNN : 360 /mm³ , ECBU : leucocytes a 100000, culture en cours .

39 - Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A- Cystite infectieuse.
- B- Sepsis sévère.
- C- Choc septique.
- D- Une neutropénie fébrile chimio-induite à point départ urinaire probable.
- E- Aucune des propositions suscitées

40 - Quel (s) mesures à entretenir en urgence chez cette patiente :

- A) Hospitalisation avec isolement bactériologique.
- B- Traitement antipyrétique avec retour à domicile.
- ☒ C- Antibiothérapie probabiliste en urgence à démarrer après résultats des prélèvements bactériologiques.
- D- Antibiothérapie en urgence probabiliste à large spectre à démarrer sans attendre les résultats des prélèvements bactériologiques.
- E- Des facteurs de croissance granulocytaires lors des prochaines séances de chimiothérapie.

41- Concernant le syndrome de lyse tumoral, il se caractérise par :

- A- Hyperkaliémie
- B- Hyperphosphorémie
- C- Hypocalcémie
- D- Hypercalcémie
- E- Hypercréatinémie

42- La chimiothérapie cytotoxique :

- A) Agit pour certaines molécules sur une phase précise du cycle cellulaire
- B) Représente une seule famille de molécules cytotoxiques
- C) Bloque le cycle cellulaire des cellules tumorales seulement
- D) se caractérise par une action très spécifique
- E) nécessite une prémédication adaptée en fonction du type de toxicité

43- Les molécules de chimiothérapie cytotoxique :

- A) Agissent en bloquant les voies de signalisation intracellulaire
- B) Activent les cellules immunitaires pour améliorer la réponse antitumorale
- C) Perforent la membrane cellulaire provoquant une lyse immédiate
- D) Agissent sur l'ADN et les protéines impliquées dans la division cellulaire
- E) Bloquent les récepteurs membranaires

44- Quel est (sont) l' (les) objectif (s) d'une chimiothérapie Palliative ?

- ✓ A. Améliorer la qualité de vie
- B. Réduire la masse tumorale avant la chirurgie
- ✓ C. Soulager les douleurs liées au cancer
- D. Traiter les micro métastases après un traitement local
- E. Contrôler les micro métastases avant un traitement local

45- l'anémie chimio induite

- A) Est la complication hématologique la plus fréquente en cancérologie
- B) Nécessite une transfusion systématique
- C) Est une complication qui peut être prévenue
- D) Nécessite un bilan spécifique
- E) Implique la correction des carences le cas échéant

46- Parmi les molécules suivantes, laquelle est la plus susceptible de provoquer une insuffisance rénale

- A) Le 5-FU
- B) Le cisplatine
- C) Le paclitaxel
- D) Le trastuzumab
- E) La doxorubicine

47- Les thérapies moléculaires ciblées :

- A) Sont dirigées contre une cible moléculaire directement impliquée dans l'oncogénèse
- B) Représentent le seul espoir thérapeutique pour certaines localisations tumorales
- C) Sont de moins en moins utilisées de nos jours
- D) Leur spectre de toxicité est différent de celui de la chimiothérapie
- E) Sont toutes classées dans la même catégorie quel que soit leur mécanisme d'action

48- Quel est le mode d'action principal des inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) ?

- A. Blocage de la polymérisation des microtubules
- B. Inhibition compétitive des sites de liaison de l'ATP
- C. Action directe sur l'ADN en inter-brin
- D. Activation des récepteurs nucléaires
- E. Action exclusive sur les récepteurs membranaires

49- Quels sont les mécanismes d'action des thérapies ciblées de type Anticorps monoclonaux?

- A) Ils empêchent la fixation des ligands sur les récepteurs
- B) Ils déclenchent l'apoptose par toxicité mitochondriale
- C) Ils bloquent l'activité enzymatique intracellulaire des récepteurs
- D) Ils entraînent une modulation du système immunitaire
- E) Ils créent des ponts entre les brins de l'ADN

50- L'immunothérapie des cancers :

- A) Vise à réactiver la réponse immunitaire antitumorale
- B) Agit exclusivement sur les cellules tumorales
- C) Agit sur les cellules immunitaires
- D) Permet de resensibiliser le système immunitaire vis-à-vis des Antigènes tumoraux
- E) se caractérise par une toxicité très fréquente

Code candidat

Nom

Prénom

Remarques :

Université Cadi Ayyad
FMM Marrakech
Année Universitaire 2025-2026
Session Janvier 2026
Oncologie-Hématologie
4ème Année Médecine

CORRECTION

16:20
23/01/26

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☒	☒
Q2	☐	☒	☐	☒	☒
Q3	☐	☐	☒	☐	☐
Q4	☒	☒	☐	☒	☒
Q5	☒	☐	☒	☒	☒
Q6	☐	☐	☒	☒	☒
Q7	☒	☒	☒	☐	☒
Q8	☒	☒	☒	☒	☐
Q9	☒	☒	☐	☐	☒
Q10	☒	☒	☐	☐	☐
Q11	☒	☐	☐	☐	☐
Q12	☒	☒	☐	☒	☒
Q13	☐	☒	☒	☒	☐
Q14	☐	☒	☐	☐	☐
Q15	☐	☒	☒	☐	☐
Q16	☐	☒	☒	☐	☐
Q17	☒	☒	☐	☒	☐
Q18	☐	☒	☐	☒	☒
Q19	☐	☒	☐	☐	☒
Q20	☒	☐	☐	☐	☐
Q21	☐	☒	☐	☐	☐
Q22	☐	☐	☒	☐	☐
Q23	☐	☐	☒	☒	☒
Q24	☐	☐	☐	☐	☒
Q25	☐	☒	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q26	☒	☒	☒	☒	☒
Q27	☐	☒	☐	☒	☒
Q28	☒	☒	☒	☒	☐
Q29	☐	☒	☐	☐	☒
Q30	☐	☐	☐	☐	☒
Q31	☐	☒	☒	☒	☐
Q32	☒	☒	☒	☐	☒
Q33	☐	☒	☒	☐	☐
Q34	☒	☐	☐	☒	☐
Q35	☐	☒	☐	☐	☐
Q36	☐	☐	☒	☐	☐
Q37	☐	☒	☒	☐	☒
Q38	☐	☒	☐	☐	☐
Q39	☐	☐	☐	☒	☐
Q40	☒	☐	☐	☒	☒
Q41	☒	☒	☒	☐	☒
Q42	☒	☐	☐	☐	☒
Q43	☐	☐	☐	☒	☐
Q44	☒	☐	☒	☐	☐
Q45	☐	☐	☒	☒	☒
Q46	☐	☒	☐	☐	☐
Q47	☒	☒	☐	☒	☐
Q48	☐	☒	☐	☐	☐
Q49	☒	☐	☐	☒	☐
Q50	☒	☐	☒	☒	☐